

Referensi

1. Bickley. Bates Guide to Physical Examination and History Taking 8th Edition. 2002-08.
2. Duijnhoven, Belle. Skills in Medicine: The Pulmonary Examination. 2009.

18. Pemeriksaan Refleks Fisiologis**Tingkat Keterampilan: 4A**

Tujuan: Menilai refleks fisiologis serta mengenali kelainannya.

Alat dan Bahan: Palu refleks.

Teknik Pemeriksaan

1. Persiapkan alat yang dibutuhkan
2. Menilai Refleks tendon (bisep, trisep, pergelangan, patella, tumit):
Tendon biceps (posisi pasien duduk)
 - a. Apabila pemeriksa tidak kidal, pegang siku pasien dengan tangan kiri.
 - b. Lengan bawah pasien harus rileks berada diatas lengan bawah pemeriksa.
 - c. Jempol kiri pemeriksa harus berada diatas tendon biscep di lipat siku pasien.
 - d. Ketuk jempol anda dengan palu refleks.
 - e. Nilai adanya kontraksi pada otot bisceps dan pergerakan lengan bawah, bandingkan kanan dan kiri.

Tendon biceps (posisi pasien berbaring)

- a. Fleksikan lengan dan letakkan lengan bawah di atas abdomen.
- b. Pastikan otot biscep dalam keadaan rileks dengan menggerakkan siku secara pasif.
- c. Tempatkan jempol atau telunjuk kiri pemeriksa pada tendon biceps di lipat siku pasien sebagai pemandu lokasi tendon otot biceps.
- d. Ketuk jari pemandu dengan palu refleks.
- f. Nilai adanya fleksi lengan bawah dan kontraksi pada otot biceps, bandingkan kanan dan kiri.

Tendon triceps (posisi pasien duduk)

- a. Fleksikan lengan bawah pasien secara pasif sehingga sikunya membentuk sudut 90°. Pegang pergelangan tangan pasien sehingga otot pasien benar-benar dalam keadaan rileks.
- b. Letakkan jari telunjuk pada tendon triceps sebagai pemandu.
- c. Ketuk jari telunjuk dengan palu refleks, sekitar 3 cm diatas olecranon.
- d. Nilai adanya ekstensi lengan bawah dan kontraksi pada otot triceps, bandingkan kanan dan kiri.

Tendon triceps (posisi pasien berbaring)

- Lengan bawah pasien diposisikan diatas dadanya dalam posisi rileks, dengan siku fleksi 90°.
- Dengan menggunakan satu tangan, pemeriksa memegang tangan atau pergelangan tangan pasien memfleksikannya sedikit lebih dari 90°, dengan terlebih dahulu mengerakkan siku pasien fleksi-ekstensi secara pasif.
- Letakkan jari telunjuk pada tendon triceps sebagai pemandu.
- Ketuk jari telunjuk dengan palu refleks, sekitar 3 cm diatas olecranon.
- Ketuk tendon triceps dengan palu refleks, sekitar 3 cm diatas olecranon.
- Nilai adanya ekstensi lengan bawah dan kontraksi pada otot triceps, bandingkan kanan dan kiri.

Pemeriksaan Refleks brachioradialis/ pergelangan tangan (pasien posisi duduk)

- Posisi awal memegang lengan pasien seperti saat melakukan pemeriksaan refleks bisceps.
- Kemudian ketuk di daerah 1 cm diatas prosesus radiostyloid dengan palu refleks.
- Nilai adanya fleksi lengan bawah dan kontraksi otot brachioradialis, bandingkan kanan dan kiri.

Pemeriksaan Refleks brachioradialis/ pergelangan tangan (pasien posisi berbaring)

- Posisi awal memegang lengan pasien seperti saat melakukan pemeriksaan refleks bisceps.
- Pegang jari telunjuk pasien dengan satu tangan dan gerakkan dengan bawah dan pergelangan tangan pasien hingga otot rileks.
- Kemudian ketuk di daerah 1 cm diatas prosesus radiostyloid dengan palu refleks.
- Nilai adanya fleksi lengan bawah dan kontraksi otot brachioradialis, bandingkan kanan dan kiri.

KPR Patella (pasien posisi duduk)

- Tungkai bawah pasien harus dalam keadaan menggantung dan rileks.
- Yakinkan otot quadriceps pasien dalam keadaan rileks.
- Ketuk tendon quadriceps dengan palu refleks, diantara patella dan tuberositas tibial.
- Nilai adanya ekstensi tungkai bawah dan kontraksi otot quadriceps, bandingkan kanan dan kiri.

Patella (pasien posisi berbaring)

- Pemeriksa menempatkan tangannya pada salah satu lutut pasien melewati bawah lutut yang akan diperiksa.
- Yakinkan tangan pemeriksa yang bebas mengecek bahwa otot quadriceps pasien dalam keadaan rileks.

Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer |

- c. Ketuk tendon quadriceps dengan palu refleks, diantara patella dan tuberositas tibial.
- d. Nilai adanya ekstensi tungkai bawah dan kontraksi otot quadriceps, bandingkan kanan dan kiri.

Tendon Achilles (pasen posisi berbaring)

- a. Letakkan kaki pasien dalam posisi menyilang, satu kaki diatas kaki lainnya.
- b. Pemeriksa memegang ujung kaki pasien dan menggerakkan pergelangan kakinya fleksi-ekstensi hingga otot rileks.
- c. Pemeriksa menekan kaki pasien sehingga kaki pasien sedikit dorso fleksi.
- d. Ketuk tendon Achilles dengan palu refleks.
- e. Nilai adanya fleksi dorsum pedis atau ekstensi plantar pedis, bandingkan kanan dan kiri.

3. Refleks abdominal

- a. Pasien berbaring dalam keadaan rileks.
- b. Goreskan ujung lancip palu refleks dengan arah dari tepi ke umbilikus di enam regio abdomen (epigastrik, mesogastrik, hipogastrik, kanan dan kiri)
- c. Nilai adanya pergerakan umbilikus yang disebabkan oleh adanya kontraksi otot abomen.

4. Refleks kremaster

- a. Pasien berbaring diatas meja periksa
- b. Goreskan ujung lancip palu refleks didaerah paha dalam dengan arah dari distal ke proksimal.
- c. Nilai bila terlihat testis terangkat, bandingkan kanan dan kiri.

5. Refleks anal

- a. Pasien berbaring dengan posisi litotomi.
- b. Dengan perlahan, goreskan ujung lancip palu refleks di sekitar anus dengan gerakan melingkar.
- c. Nilai adanya kontraksi dari muskulus sfingter ani eksternal.

6. *Snout reflex* (refleks regresi)

- a. Dengan perlahan ketukkan jari pemeriksa diantara hidung dan mulut pasien.
- b. Nilai respon mulut pasien berupa gerakan mencucu.

Analisis Hasil Pemeriksaan

1. Penilaian hasil pemeriksaan refleks:

- a. 0 : tidak ada refleks
- b. 1 : refleks lemah
- c. 2 : refleks normal
- d. 3 : refleks cepat
- e. 4 : refleks cepat dengan disertai klonus (beberapa kontraksi pendek dan ritmik)



2. Kelainan yang dapat ditemukan antara lain:
 - a. Hiporefleksia: Refleks menurun pada kelainan *lower motor neuron*.
 - b. Arefleksia. Dapat disebabkan oleh:
 - Lesi yang melibatkan saraf tepi (jalur aferen dan/atau eferen lengkung refleks).
 - Lesi pada bagian sentral (spinal root) dari lengkung refleks, seperti syringomelia.
 - Fase akut dari cedera spinal.
 - Koma dalam.
 - Arefleksia kongenital, biasanya pada tungkai.
 - c. Hiperefleksia: refleks meningkat pada gangguan yang melibatkan *upper motor neuron*.
 - d. Adanya klonus merupakan tanda patologis dan indikasi adanya lesi pada *central motor neuron* (CML) diatas refleks cabang spinal. Pada bayi baru lahir atau pasien dengan refleks yang sangat cepat, klonus bertahan selama 3-4 ketukan didapatkan dikedua sisi.

Referensi

1. Bickley. Bates Guide to Physical Examination and History Taking 8th Edition. 2002-08.
2. Duijnhoven, Belle. Skills in Medicine: Neurology Examination. 2009.

19. Pemeriksaan Refleks Patologis

Tingkat Keterampilan: 4A

Tujuan: Melakukan pemeriksaan

1. Hofmann tromner
2. Babinski
3. Oppenheim
4. Chaddock
5. Gordon
6. Schaefer
7. Gonda

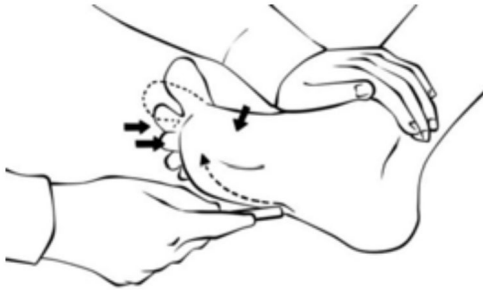
Alat dan Bahan: palu refleks

Teknik pemeriksaan

1. Siapkan alat dan bahan.
2. Jelaskan kepada pasien jenis dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan.
3. Mencuci tangan.



4. Refleks Hoffman tromner
 - a. Minta pasien untuk melakukan hiperekstensi di pergelangan tangannya, kemudian ujung jari tengah disentil (snapped)
 - b. Lihat gerakan jari lainnya, hasil positif adalah bila jari-jari fleksi dan ibu jari adduksi
5. Kemudian, minta pasien berbaring di meja periksa dengan kedua tungkai diluruskan.
6. Refleks babinski
 - a. Pemeriksa memegang pergelangan kaki untuk memfiksasi kaki pasien.
 - b. Gunakan ujung tajam palu refleks untuk menggores telapak kaki bagian lateral, mulai tumit menuju pangkal jempol kaki.
 - c. Goresan dilakukan secara perlahan dan tidak sampai mengakibatkan rasa nyeri.
 - d. Lakukan prosedur pemeriksaan ini pada kaki lainnya dan bandingkan hasilnya.



Gambar 21. Refleks Babinski

7. Refleks Chaddock
Rangsangan diberikan dengan cara menggoreskan ujung runcing palu refleks di bagian lateral maleolus.



Gambar 22. Refleks Chaddock

8. Refleks Oppenheim

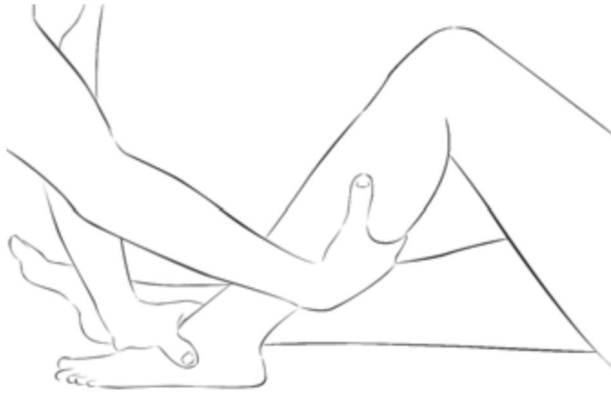
Rangsangan diberikan dengan mengurut dengan kuat tibia dan otot tibialis anterior dari arah proksimal ke distal.



Gambar 23. Refleks Oppenheim

9. Refleks Gordon

Rangsangan diberikan dengan mencubit otot gastroknemius.



Gambar 24. Refleks Gordon

10. Refleks Scaeffler

Rangsangan diberikan dengan mencubit tendon achilles



Gambar 25. Refleks Scaeffler

11. Refleks Gonda

Rangsangan diberikan dengan menekan klah satu jari kaki dan melepaskannya.

Analisis hasil pemeriksaan

- Refleks Hoffman tromner positif bilateral pada 25% orang normal, sedangkan bila unilateral merupakan indikasi lesi UMN diatas segmen servikal VIII.
- Refleks dikatakan positif apabila pada saat dilakukan manuver-manuver diatas didapatkan gerakan dorsofleksi ibu jari kaki yang dapat disertai dengan gerak



Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer |

mekarnya jari-jari lainnya. Refleks-refleks ini positif pada lesi traktus piramidalis.

Referensi

1. Bickley, LS. Szilagyi PG: *Bates' Guide to Physical Examination and History Taking*, 10th edition. Lippincott Williams & Wilkins, China, 2009.
2. Duijnhoven, Belle. *Skills in Medicine: The Neurology Examination*. 2009
3. Lumbantobing. *Neurologi Klinik Pemeriksaan Fisik dan Mental*. Jakarta. Balai penerbit FKUI. 2008. p46-47.

20. Pemeriksaan Sistem Sensorik (Eksteroseptif dan Proprioseptif)

Tingkat Keterampilan: 4A

Tujuan: menilai fungsi sistem sensorik.

Alat dan Bahan

1. Tusuk gigi
2. *Cotton bud*
3. Dua buah tabung reaksi
4. Air panas
5. Air dingin
6. Garpu tala

Teknik Pemeriksaan

Disusun berdasar dermatom, mulai dari C3 untuk rangsang nyeri, raba halus dan suhu

1. Siapkan alat dan bahan.
2. Jelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan prosedurnya.
3. Penilaian sensasi nyeri:
 - a. Biarkan pasien merasakan perbedaan rangsangan saat pemeriksa menekan ujung runcing tusuk gigi dan ujung tumpul *cotton bud* pada area dimana pemeriksa yakin tidak terdapat defisit sensorik.
 - b. Minta pasien menutup mata.
 - c. Kemudian lakukan prosedur ini di beberapa tempat dengan menekankan ujung tajam tusuk gigi dan ujung tumpul *cotton bud* secara bergantian dan acak. Tanyakan kepada pasien setiap pemeriksa menekankan salah satu benda diatas, apakah pasien merasakan tajam atau tumpul.
 - d. Apabila terdapat gangguan membedakan sensasi tajam dan tumpul, gunakan istilah hipalgesia atau analgesia dan catat bagian tubuh yang mengalami gangguan.
4. Penilaian sensasi suhu:
 - a. Pada pemeriksaan ini, siapkan dua buah tabung reaksi yang berisi air dingin

mekarnya jari-jari lainnya. Refleks-refleks ini positif pada lesi traktus piramidalis.

Referensi

1. Bickley, LS. Szilagyi PG: *Bates' Guide to Physical Examination and History Taking*, 10th edition. Lippincott Williams & Wilkins, China, 2009.
2. Duijnhoven, Belle. *Skills in Medicine: The Neurology Examination*. 2009
3. Lumbantobing. *Neurologi Klinik Pemeriksaan Fisik dan Mental*. Jakarta. Balai penerbit FKUI. 2008. p46-47.

20. Pemeriksaan Sistem Sensorik (Eksteroseptif dan Proprioseptif)

Tingkat Keterampilan: 4A

Tujuan: menilai fungsi sistem sensorik.

Alat dan Bahan

1. Tusuk gigi
2. *Cotton bud*
3. Dua buah tabung reaksi
4. Air panas
5. Air dingin
6. Garpu tala

Teknik Pemeriksaan

Disusun berdasar dermatom, mulai dari C3 untuk rangsang nyeri, raba halus dan suhu

1. Siapkan alat dan bahan.
2. Jelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan prosedurnya.
3. Penilaian sensasi nyeri:
 - a. Biarkan pasien merasakan perbedaan rangsangan saat pemeriksa menekan ujung runcing tusuk gigi dan ujung tumpul *cotton bud* pada area dimana pemeriksa yakin tidak terdapat defisit sensorik.
 - b. Minta pasien menutup mata.
 - c. Kemudian lakukan prosedur ini di beberapa tempat dengan menekan ujung tajam tusuk gigi dan ujung tumpul *cotton bud* secara bergantian dan acak. Tanyakan kepada pasien setiap pemeriksa menekan salah satu benda diatas, apakah pasien merasakan tajam atau tumpul.
 - d. Apabila terdapat gangguan membedakan sensasi tajam dan tumpul, gunakan istilah hipalgesia atau analgesia dan catat bagian tubuh yang mengalami gangguan.
4. Penilaian sensasi suhu:
 - a. Pada pemeriksaan ini, siapkan dua buah tabung reaksi yang berisi air dingin

dan air panas.

- b. Biarkan pasien merasakan perbedaan rangsangan suhu yang diberikan pada area dimana pemeriksa yakin tidak terdapat defisit sensorik.
 - c. Minta pasien menutup mata.
 - d. Sentuhkan rangsangan panas dan dingin di beberapa area pada tubuh pasien, tanyakan apa yang pasien rasakan setiap kali memberikan rangsangan.
 - e. Catat bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan dalam membedakan rangsangan suhu.
5. Penilaian sensasi raba halus:
- a. Untuk pemeriksaan ini, gunakan ujung *cotton bud*.
 - b. Minta pasien untuk menutup mata.
 - c. Selalu sentuh pasien dengan sentuhan ringan, jangan di tekan.
 - d. Minta pasien mengatakan "ya" setiap kali pasien merasakan kontak.
 - e. Minta pasien untuk menyebutkan bila pasien merasakan sensasi yang berbeda saat disentuh.
 - f. Catat bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan dalam membedakan rangsangan suhu.
6. Penilaian rasa posisi (propioseptif):
- a. Minta pasien menutup mata.
 - b. Pegang jempol kaki pasien diantara jempol dan jari telunjuk pemeriksa.
 - c. Pastikan bahwa pemeriksa tidak menyentuh jari pasien yang lainnya.
 - d. Gerakkan jempol kaki pasien dan tanyakan bila pasien merasakan gerakan tersebut dan menyebutkan arahnya.
 - e. Lakukan juga prosedur ini pada ekstremitas atas.
 - f. Lakukan pula pemeriksaan getar dan posisi dua tempat (*two point discrimination*).

Analisis Hasil Pemeriksaan

1. Dengan menandai area yang mengalami defisit neurologis, pemeriksa dapat mengetahui adanya kelainan mononeuropathy, polineuropathy, lesi saraf tepi maupun lesi pada saraf sentral.
2. Penilaian sensasi nyeri dan suhu merupakan penilaian fungsi sensoris spinothalamikus sehingga kelainan pada pemeriksaan ini merupakan tanda adanya gangguan pada fungsi sensoris spinothalamikus.
3. Penilaian sensasi raba dan posisi (propioseptif) merupakan penilaian fungsi sensoris kolumna dorsalis sehingga kelainan pada pemeriksaan ini merupakan tanda adanya gangguan pada fungsi sensoris kolumna dorsalis.
4. Kondisi yang melibatkan korda spinalis dapat menyebabkan gangguan pada salah satu fungsi tersebut, misalnya fungsi sensoris spinothalamikus yang intak namun ada defisit dari fungsi sensoris kolumna dorsalis.
5. Berdasarkan lokasi gangguan fungsi sensoris, pemeriksa dapat memperkirakan kemungkinan letak lesi.



Referensi

1. Bickley. *Bates Guide to Physical Examination and History Taking* 8th Edition. 2002-08.
2. Duijnhoven, Belle. *Skills in Medicine: Neurology Examination*. 2009.

21. Pemeriksaan Sistem Motorik

Tingkat Keterampilan: 4A

Tujuan

1. Menilai postur dan habitus (lihat Bab III *General Survey*).
2. Menilai adanya gerakan involunter.
3. Menilai tonus otot.
4. Menilai kekuatan otot.

Alat dan Bahan: -

Teknik Pemeriksaan

1. Siapkan alat dan bahan.
2. Jelaskan kepada pasien jenis dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan.
3. Cuci tangan sebelum melakukan prosedur pemeriksaan.
4. Inspeksi:
 1. Minta pasien berdiri dengan santai.
 2. Nilai postur tubuh pasien dan kontur otot. Amati tanda-tanda adanya hipertrofi maupun atrofi otot.
 3. Nilai adanya gerakan involunter seperti tremor, fasikulasi dan gerakan koreiform.
5. Penilaian tonus otot:
 - a. Persiapkan pasien dalam posisi berbaring, se-rileks mungkin.
 - b. Pegang lengan pasien dengan menempatkan tangan pemeriksa disekitar pergelangan tangan pasien (hanya di sendi siku dan lutut;sendi-sendi besar). Siku dalam keadaan menempel pada meja periksa.
 - c. Tempatkan jari-jari pemeriksa pada tendon biceps.
 - d. Fleksi dan ekstensikan sendi siku beberapa kali.
 - e. Nilai tonus otot-otot lengan atas pasien dan bandingkan kanan dan kiri.
 - f. Nilai juga tonus otot-otot tungkai atas dengan fleksi dan ekstensi secara pasif sendi panggul dan lutut.
6. Penilaian kekuatan otot:
 - a. Untuk menilai kekuatan otot, pasien harus mengkontraksikan ototnya secara maksimal.
 - b. Coba untuk membuat tahanan terhadap otot yang diperiksa dengan menggunakan tangan pemeriksa.
 - c. Saat menilai kekuatan otot pasien, coba untuk membuat perbandingan



dengan kekuatan pemeriksa.

- Buat penilaian semi kuantitatif berdasarkan skala 0-5.

Area kepala dan leher

Lihat BAB SISTEM SARAF dalam pemeriksaan saraf kranial

Ekstremitas atas

M. serratus anterior

- Pasien berdiri dengan kedua tangan diregangkan dan disandarkan pada dinding. Tinggi tangan yang menempel pada dinding kurang lebih sejajar dengan bahu.
- Minta pasien mendorong tembok. Nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

M. deltoideus

- Minta pasien untuk mengekstensikan kedua lengannya ke arah samping dan minta ia untuk mempertahankan posisi tersebut.
- Pemeriksa mencoba menekan kedua lengan pasien ke bawah dan nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

M. biceps brachii

- Minta pasien memfleksikan sendi sikunya dengan maksimal ke arah bahu, dengan posisi supinasi lengan bawah.
- Pemeriksa mencoba meluruskan lengan pasien dan nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

M. triceps brachii

- Minta pasien mengekstensikan maksimal lengannya pada sendi siku.
- Pemeriksa mencoba menekuk lengan pasien pada sendi siku, nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

Muskulus-muskulus ekstensor pergelangan tangan

- Minta pasien untuk mengekstensikan pergelangan tangannya dengan pronasi lengan bawah.
- Pemeriksa mencoba memfleksikan pergelangan tangan, nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

Muskulus-muskulus flektor pergelangan tangan

- Minta pasien meletakkan lengan bawahnya diatas meja pada posisi supinasi dan fleksi pada sendi pergelangan tangan.
- Pemeriksa mencoba mengekstensikan pergelangan tangan pasien, nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

Muskulus-muskulus flektor jari

- Minta pasien untuk menggenggam jari pemeriksa sekuatnya.

- Pemeriksa mencoba melepaskan jari-jarinya dan nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

Muskulus-muskulus ekstensor jari



Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer |

- b. Periksa mencoba melepaskan jari-jarinya dan nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

Muskulus-muskulus ekstensor jari

- a. Minta pasien meluruskan sendi-sendi jari tangannya.
- b. Periksa mencoba memfleksikan sendi-sendi jari pasien dan nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

M. opponens pollicis

- a. Minta pasien untuk menautkan ujung jempol dan ujung kelingkingnya sehingga membentuk lingkaran.
- b. Periksa mencoba melepaskan lingkaran tersebut dengan jarinya, nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

Muskulus-muskulus interoseus

- a. Minta pasien untuk mengekstensikan seluruh jarinya dan regangkan.
- b. Periksa melakukan hal yang sama dan menempatkan jari-jarinya diantara jari-jari pasien.
- c. Minta pasien untuk merapatkan jari-jarinya sekuatnya.
- d. Nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

Ekstremitas bawah*M. gluteus medius dan m. gluteus minimus*

- a. Minta pasien untuk berdiri tegak.
- b. Amati apakah tubuh bagian atas pasien terlihat membungkuk.
- c. Amati apakah pasien dapat mempertahankan pelvis pada posisi sejajar garis horizontal.

M. iliopsoas

- a. Minta pasien berbaring di meja periksa dengan posisi sendi panggul fleksi maksimal.
- b. Periksa mencoba meluruskan sendi panggul pasien dan nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

M. quadriceps

- a. Periksa berdiri di sebelah kanan pasien.
- b. Tempatkan tangan kanan pemeriksa pada pergelangan kaki kanan pasien yang sedang dalam posisi lurus, angkat sedikit kaki pasien.
- c. Letakkan tangan kiri pemeriksa dibawah kaki kanan pasien tepat melewati bawah lutut dan pegang lutut kaki kiri pasien.
- d. Tangan kanan pemeriksa mencoba untuk menekuk sendi lutut kanan pasien dan nilai kekuatan ototnya.
- e. Lakukan prosedur yang sama untuk kaki sebelah kiri dan bandingkan kekuatannya.

M. femoral adductor

- a. Pasien berbaring dengan posisi fleksi pada sendi panggul dan lutut. Rapatkan kedua lutut.

Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer |

M. femoral adductor

- Pasien berbaring dengan posisi fleksi pada sendi panggul dan lutut. Rapatkan kedua lutut.
- Pemeriksa mencoba memisahkan kedua lutut pasien dan nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

M. hamstrings

- Pasien berbaring dengan posisi fleksi pada sendi panggul dan fleksi maksimal pada sendi lutut sehingga tumit pasien menyentuh paha atas.
- Pemeriksa mencoba mengekstensikan sendi lutut pasien dan nilai kekuatannya, bandingkan kanan dan kiri.

M. tibialis anterior dan m. extensor digitorum

- Pasien berbaring dengan posisi kedua tungkai ekstensi. Minta pasien untuk menarik telapak kakinya ke arah kranial sehingga fleksi pada sendi pergelangan kaki (dorso fleksi).
- Pemeriksa mencoba mendorong kaki pasien menjauhi tubuh dan nilai kekuatannya, bandingkan kanan dan kiri.

M. gastrocnemius

- Pasien berbaring dengan posisi kedua tungkai ekstensi. Minta pasien untuk meluruskan telapak kakinya seperti menginjak rem (plantar fleksi).
- Pemeriksa mencoba mendorong kaki pasien mendekati tubuh dan nilai kekuatannya, bandingkan kanan dan kiri.

M. peroneal

- Tangan pemeriksa diletakkan di sisi luar kaki pasien sejajar jari kelingking.
- Minta pasien mendorong tangan pemeriksa sekuatnya dan nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

M. extensor hallucis longus

- Tangan pemeriksa diletakkan di sisi dalam kaki pasien sejajar jempol.
- Minta pasien mendorong tangan pemeriksa sekuatnya dan nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

M. flexor hallucis longus

- Minta pasien untuk memfleksikan kedua jempol kakinya.
- Pemeriksa mencoba meluruskan kedua jempol pasien dan nilai kekuatan ototnya, bandingkan kanan dan kiri.

Analisis Hasil Pemeriksaan

- Atrofi otot dapat ditemukan pada:
 - Penyakit kronis dan malnutrisi
 - Penyakit Muskular

Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer |

- Setelah terjadi kerusakan saraf perifer
- Setelah kerusakan traktus kortikospinal

Bentuk atrofi dapat berupa:

- Atrofi asimetris terjadi pada contohnya mononeuropathy.
- Atrofi simetris terjadi pada contohnya penyakit muskular.

2. Gerakan involunter:

- Fasikulasi merupakan kontraksi otot yang tidak beraturan. Kadaan ini dapat mengindikasikan adanya lesi motor neuron (contohnya poliomielitis, *amyotrophic lateral sclerosis*) namun dapat juga tidak memiliki makna patologis.
- Tremor merupakan gerakan involunter yang relatif berirama, yang kurang lebih dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

- *Resting (Static) Tremors*

Tremor ini paling mencolok saat istirahat dan dapat berkurang atau menghilang dengan adanya pergerakan.

- *Postural Tremors*

Tremor ini terlihat saat bagian yang terkena aktif menjaga postur. Contohnya tremor pada hipertiroid dan tremor pada kecemasan atau kelelahan. Tremor ini dapat memburuk bila bagian yang terkena disengaja untuk mempertahankan suatu postur tertentu.

- *Intention Tremors*

Merupakan tremor yang hilang saat istirahat dan timbul saat aktivitas dan semakin memburuk bila target yang akan disentuh semakin dekat. Penyebabnya antara lain gangguan jaras serebelar seperti pada *multiple sclerosis*.



Gambar 26. Tremor

c. *Tick*

Tics merupakan gerakan yang singkat, berulang, stereotip, gerakan terkoordinasi yang terjadi pada interval yang tidak teratur. Contohnya termasuk berulang mengedip, meringis, dan mengangkat bahu bahu. Penyebab termasuk sindrom dan obat-obatan seperti Tourette, fenotiazin dan amfetamin.



Gambar 27. Tick

d. *Chorea*

Gerakan Choreiform merupakan gerakan yang singkat, cepat, tidak teratur, dan tak terduga. Terjadi saat istirahat atau mengganggu gerakan terkoordinasi normal. Tidak seperti tics, *chorea* jarang berulang. Wajah, kepala, lengan bawah, dan tangan sering terlibat. Penyebabnya termasuk chorea Sydenham (dengan demam rematik) dan penyakit Huntington.



Gambar 28. Chorea

e. *Athetosis*

Gerakan Athetoid lebih lambat dan lebih memutar dan menggeliat dibandingkan gerakan choreiform, dan memiliki amplitudo yang lebih besar. Paling sering melibatkan wajah dan ekstremitas distal. Athetosis sering dikaitkan dengan spastisitas. Penyebabnya antara lain *cerebral palsy*.



Gambar 29. Athetosis

3. Penilaian tonus otot:

- Rigiditas:** adanya tahanan pada seluruh pergerakan. Kondisi ini menandakan adanya keterlibatan sistem ekstrapiramidal.
- Spastisitas:** adanya tahanan pada bagian tertentu dari suatu gerakan, letaknya dapat bervariasi. kondisi ini menandakan adanya keterlibatan jaras kortikospinal (sistem piramidal).
- Hipotonia:** pada keadaan relaksasi pun biasanya otot teraba sedikit berkontraksi. Namun konduksi sensoris ke otot dapat terganggu, misalnya pada kerusakan saraf tepi yang berat atau kerusakan akut jalur kortikospinal, sehingga tonus otot dapat menghilang.

4. Penilaian pemeriksaan kekuatan otot:

- Tidak ada pergerakan sama sekali, tonus otot tidak teraba.
- Tonus otot teraba namun tidak ada pergerakan. Hanya bisa menggerakkan sendi kecil
- Terdapat pergerakan namun tidak dapat melawan gravitasi (gerakan menggeser ke kanan dan kiri). Hanya bisa menggeser di permukaan.
- Kekuatan otot hanya cukup untuk melawan gravitasi namun tidak dapat melawan tahanan ringan.
- Kekuatan otot dapat menahan tahanan ringan namun tidak dapat melawan tahanan maksimal.
- Kekuatan otot dapat menahan tahanan maksimal.

Referensi

- Bickley. Bates Guide to Physical Examination and History Taking 8th Edition. 2002-08.
- Duijnhoven, Belle. Skills in Medicine: Neurology Examination. 2009.

22. Pemeriksaan Koordinasi

Tingkat Keterampilan: 4A

Tujuan: Menilai fungsi koordinasi.

Alat dan Bahan: -

Teknik Pemeriksaan

- Jelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan prosedurnya.
- Inspeksi cara berjalan (gait):
 - Minta pasien untuk berjalan melintasi ruangan beberapa kali.
 - Amati cara berjalan pasien, pola kontak kaki dengan lantai, ayunan tangan dan lebar langkah.
- Pemeriksaan tandem gait:
 - Minta pasien untuk berjalan dalam satu garis lurus dengan cara ujung tumit menyentuh ujung jempol kaki dibelakangnya. Bila dibutuhkan, berikan contoh kepada pasien.
 - Amati cara berjalan pasien. Perhatikan bilamana pasien terlihat kehilangan keseimbangan.
- Tes Romberg dan Romberg dipertajam:
 - Minta pasien berdiri dengan kedua kaki dirapatkan.
 - Pemeriksa berdiri di belakang pasien dengan posisi tangan pemeriksa berada di sisi pasien tanpa menyentuhnya.
 - Minta pasien untuk merentangkan kedua tangannya ke depan sejajar bahu dengan posisi supinasi.
 - Instruksikan kepada pasien untuk mempertahankan posisi kedua tangannya.
 - Bila pasien tidak terjatuh saat dilakukan pemeriksaan dengan mata terbuka, minta pasien untuk menutup kedua matanya.
 - Amati bila pasien kehilangan keseimbangan atau terjatuh. Nilai arah jatuh atau ayunan pasien.
- Tes Telunjuk-Hidung:
 - Minta pasien menutup mata dan tentangkan tangan kanan jauh ke samping.
 - Minta pasien menyentuh hidungnya dengan jari telunjuk kanan, ulangi beberapa kali. Lakukan prosedur yang sama terhadap tangan kiri.
 - Nilai tandatanda hipermetria atau kecenderungan tremor saat pasien melakukan prosedur diatas.
 - Bila pemeriksa menemukan tanda hipermetria atau tremor, minta pasien melakukan prosedur pemeriksaan dengan mata terbuka.
 - Nilai apakah dengan mata terbuka pasien lebih mudah melakukan prosedur pemeriksaan. Bandingkan kanan dan kiri.

6. Tes Tumit-Lutut:

- Minta pasien untuk menutup kedua matanya, kemudian menempatkan tumit

6. Tes Tumit-Lutut:
 - a. Minta pasien untuk menutup kedua matanya, kemudian menempatkan tumit kanan di atas lutut kiri.
 - b. Minta pasien untuk menurunkan tumitnya menyusuri tungkai bawah kaki kiri kebawah.
 - c. Lakukan rosedur bergantian dengan kaki kiri.
 - d. Nilai bila pasien menunjukkan tanda-tanda hipermetria atau ataksia, yaitu bila tumit berkali-kali terjatuh dari jalurnya pada tungkai bawah.
 - e. Bila pemeriksa menemukan tanda hipermetria atau ataksia, minta pasien melakukan prosedur pemeriksaan dengan mata terbuka.
 - f. Bandingkan kanan dan kiri.
7. Pemeriksaan Disdiadokokinesis:
 - a. Minta pasien melakukan gerakan tangan pronasi dan supinasi. Tangan kanan dimulai dari pronasi, tangan kiri dimulai dari supinasi, lakukan gerakan ini secepat mungkin.
 - b. Bila diperlukan pemeriksa boleh memberikan contoh pemeriksaan terhadap pasien.
 - c. Bandingkan kanan dan kiri.

Analisis Hasil Pemeriksaan

1. Keseimbangan pasien dipengaruhi oleh fungsi cerebellum dan sistem vestibular, serta propriosptif ekstremitas bawah, sehingga kelainan pada keseimbangan berhubungan dengan gangguan pada sistem-sistem tersebut.
2. Pola kontak kaki-lantai. Kondisi yang berhubungan dengan N.peroneal dapat menyebabkan *drop foot*. Pada keadaan ini, saat berjalan bagian kaki pasien yang lebih dulu menyentuh lantai adalah jempol kaki, diikuti telapak kaki, terakhir tumit.
3. Jarak antar langkah dapat memendek pada pasien dengan penyakit Parkinson. Pada keadaan ii juga dapat dilihat ayunan tangan berkurang saat pasien berjalan.
4. Pada pemeriksaan Romberg, dinyatakan positif bila pasien terlihat berayun atau pemeriksa harus memegang pasien untuk mencegah pasien terjatuh.
5. Apabila pasien terganggu koordinasinya hanya saat pasien menutup mata, maka pasien mengalami gangguan koordinasi karena proprioseptif yang tidak adekuat. Kondisi ini juga dikenal dengan ataksia sensoris.
6. Bila gangguan koordinasi meningkat saat pasien menutup mata, maka pasien mengalami gangguan koordinasi disebabkan oleh kondisi vestibular.
7. Bila gangguan koordinasi sama saat pasien menutup maupun membuka mata, maka gangguan koordinasi ini disebabkan oleh kondisi cerebelar.
8. Tes telunjuk hidung tidak terganggu pada pasien dengan gangguan ekstrapiramidal, namun mungkin terdapat tremor yang hilang bila pasien diminta melakukan gerakan yang bertujuan. Namun saat berdiri dan berjalan, pasien mengalami kesulitan akibat adanya gerakan involunter yang berlebihan, seperti pada pasien Parkinson.

Referensi

1. Bickley, Bates Guide to Physical Examination and History Taking 8th Edition.

Referensi

1. Bickley. Bates Guide to Physical Examination and History Taking 8th Edition. 2002-08.
2. Duijnhoven, Belle. Skills in Medicine: Neurology Examination. 2009.

23. Pemeriksaan Fungsi Luluh

Tingkat Keterampilan: 4A

Tujuan: menilai fungsi koordinasi.

Alat dan Bahan: -

Teknik Pemeriksaan

1. Jelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan prosedurnya.
2. Inspeksi cara berjalan (gait):
 - a. Minta pasien untuk berjalan melintasi ruangan beberapa kali.
 - b. Amati cara berjalan pasien, pola kontak kaki dengan lantai, ayunan tangan dan lebar langkah.
3. Pemeriksaan tandem gait:
 - a. Minta pasien untuk berjalan dalam satu garis lurus dengan cara ujung tumit menyentuh ujung jempol kaki dibelakangnya. Bila dibutuhkan, berikan contoh kepada pasien.
 - b. Amati cara berjalan pasien. Perhatikan bilamana pasien terlihat kehilangan keseimbangan.
4. Tes Romberg dan Romberg dipertajam:
 - a. Minta pasien berdiri dengan kedua kaki dirapatkan.
 - b. Periksa berdiri di belakang pasien dengan posisi tangan pemeriksa berada di sisi pasien tanpa menyentuhnya.
 - c. Minta pasien untuk merentangkan kedua tangannya ke depan sejajar bahu dengan posisi supinasi.
 - d. Instruksikan kepada pasien untuk mempertahankan posisi kedua tangannya.
 - e. Bila pasien tidak terjatuh saat dilakukan pemeriksaan dengan mata terbuka, minta pasien untuk menutup kedua matanya.
 - f. Amati bila pasien kehilangan keseimbangan atau terjatuh. Nilai arah jatuh atau ayunan pasien.
5. Tes Telunjuk-Hidung:
 - a. Minta pasien menutup mata dan tentangkan tangan kanan jauh ke samping.
 - b. Minta pasien menyentuh hidungnya dengan jari telunjuk kanan, ulangi beberapa kali. Lakukan prosedur yang sama terhadap tangan kiri.
 - c. Nilai tandatanda hipermetria atau kecenderungan tremor saat pasien melakukan prosedur diatas.
 - d. Bila pemeriksa menemukan tanda hipermetria atau tremor, minta pasien

melakukan prosedur pemeriksaan dengan mata terbuka.

- e. Nilai apakah dengan mata terbuka pasien lebih mudah melakukan prosedur pemeriksaan. Bandingkan kanan dan kiri.
6. Tes Tanduk Lurus.

Referensi

1. Bickley. Bates Guide to Physical Examination and History Taking 8th Edition. 2002-08.
2. Duijnhoven, Belle. Skills in Medicine: Neurology Examination. 2009.

23. Pemeriksaan Fungsi Luhur

Tingkat Keterampilan: 4A

Tujuan: menilai fungsi koordinasi.

Alat dan Bahan: -

Teknik Pemeriksaan

1. Jelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan prosedurnya.
2. Inspeksi cara berjalan (gait):
 - a. Minta pasien untuk berjalan melintasi ruangan beberapa kali.
 - b. Amati cara berjalan pasien, pola kontak kaki dengan lantai, ayunan tangan dan lebar langkah.
3. Pemeriksaan tandem gait:
 - a. Minta pasien untuk berjalan dalam satu garis lurus dengan cara ujung tumit menyentuh ujung jempol kaki dibelakangnya. Bila dibutuhkan, berikan contoh kepada pasien.
 - b. Amati cara berjalan pasien. Perhatikan bilamana pasien terlihat kehilangan keseimbangan.
4. Tes Romberg dan Romberg dipertajam:
 - a. Minta pasien berdiri dengan kedua kaki dirapatkan.
 - b. Periksa berdiri di belakang pasien dengan posisi tangan pemeriksa berada di sisi pasien tanpa menyentuhnya.
 - c. Minta pasien untuk merentangkan kedua tangannya ke depan sejajar bahu dengan posisi supinasi.
 - d. Instruksikan kepada pasien untuk mempertahankan posisi kedua tangannya.
 - e. Bila pasien tidak terjatuh saat dilakukan pemeriksaan dengan mata terbuka, minta pasien untuk menutup kedua matanya.
 - f. Amati bila pasien kehilangan keseimbangan atau terjatuh. Nilai arah jatuh atau ayunan pasien.
5. Tes Telunjuk-Hidung:
 - a. Minta pasien menutup mata dan tentangkan tangan kanan jauh ke samping.
 - b. Minta pasien menyentuh hidungnya dengan jari telunjuk kanan, ulangi beberapa kali. Lakukan prosedur yang sama terhadap tangan kiri.
 - c. Nilai tandatanda hipermetria atau kecenderungan tremor saat pasien melakukan prosedur diatas.
 - d. Bila pemeriksa menemukan tanda hipermetria atau tremor, minta pasien

melakukan prosedur pemeriksaan dengan mata terbuka.

- e. Nilai apakah dengan mata terbuka pasien lebih mudah melakukan prosedur pemeriksaan. Bandingkan kanan dan kiri.
6. Tes Tanduk Lateral.

Referensi

1. Bickley. Bates Guide to Physical Examination and History Taking 8th Edition. 2002-08.
2. Duijnhoven, Belle. Skills in Medicine: Neurology Examination. 2009.

23. Pemeriksaan Fungsi Luhur

Tingkat Keterampilan: 4A

Tujuan: menilai fungsi koordinasi.

Alat dan Bahan: -

Teknik Pemeriksaan

1. Jelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan prosedurnya.
2. Inspeksi cara berjalan (gait):
 - a. Minta pasien untuk berjalan melintasi ruangan beberapa kali.
 - b. Amati cara berjalan pasien, pola kontak kaki dengan lantai, ayunan tangan dan lebar langkah.
3. Pemeriksaan tandem gait:
 - a. Minta pasien untuk berjalan dalam satu garis lurus dengan cara ujung tumit menyentuh ujung jempol kaki dibelakangnya. Bila dibutuhkan, berikan contoh kepada pasien.
 - b. Amati cara berjalan pasien. Perhatikan bilamana pasien terlihat kehilangan keseimbangan.
4. Tes Romberg dan Romberg dipertajam:
 - a. Minta pasien berdiri dengan kedua kaki dirapatkan.
 - b. Periksa berdiri di belakang pasien dengan posisi tangan pemeriksa berada di sisi pasien tanpa menyentuhnya.
 - c. Minta pasien untuk merentangkan kedua tangannya ke depan sejajar bahu dengan posisi supinasi.
 - d. Instruksikan kepada pasien untuk mempertahankan posisi kedua tangannya.
 - e. Bila pasien tidak terjatuh saat dilakukan pemeriksaan dengan mata terbuka, minta pasien untuk menutup kedua matanya.
 - f. Amati bila pasien kehilangan keseimbangan atau terjatuh. Nilai arah jatuh atau ayunan pasien.
5. Tes Telunjuk-Hidung:
 - a. Minta pasien menutup mata dan tentangkan tangan kanan jauh ke samping.
 - b. Minta pasien menyentuh hidungnya dengan jari telunjuk kanan, ulangi beberapa kali. Lakukan prosedur yang sama terhadap tangan kiri.
 - c. Nilai tandatanda hipermetria atau kecenderungan tremor saat pasien melakukan prosedur diatas.
 - d. Bila pemeriksa menemukan tanda hipermetria atau tremor, minta pasien

melakukan prosedur pemeriksaan dengan mata terbuka.

- e. Nilai apakah dengan mata terbuka pasien lebih mudah melakukan prosedur pemeriksaan. Bandingkan kanan dan kiri.
6. Tes Tanduk Lateral.



Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer |

- e. melakukan prosedur pemeriksaan dengan mata terbuka.
 - f. Nilai apakah dengan mata terbuka pasien lebih mudah melakukan prosedur pemeriksaan. Bandingkan kanan dan kiri.
6. Tes Tumit-Lutut:
- a. Minta pasien untuk menutup kedua matanya, kemudian menempatkan tumit kanan di atas lutut kiri.
 - b. Minta pasien untuk menurunkan tumitnya menyusuri tungkai bawah kaki kiri kebawah.
 - c. Lakukan rosedur bergantian dengan kaki kiri.
 - d. Nilai bila pasien menunjukkan tanda-tanda hipermetria atau ataksia, yaitu bila tumit berkali-kali terjatuh dari jalurnya pada tungkai bawah.
 - e. Bila pemeriksa menemukan tanda hipermetria atau ataksia, minta pasien melakukan prosedur pemeriksaan dengan mata terbuka.
 - f. Bandingkan kanan dan kiri.
7. Pemeriksaan Disdiadokokinesis:
- a. Minta pasien melakukan perubahan gerakan misalnya gerakan tangan pronasi dan supinasi. Tangan kanan dimulai dari pronasi, tangan kiri dimulai dari supinasi, lakukan gerakan ini secepat mungkin.
 - b. Bila diperlukan pemeriksa boleh memberikan contoh pemeriksaan terhadap pasien.
 - c. Bandingkan kanan dan kiri.

Analisis Hasil Pemeriksaan

1. Keseimbangan pasien dipengaruhi oleh fungsi cerebellum dan sistem vestibular, serta propriosptif ekstremitas bawah, sehingga kelainan pada keseimbangan berhubungan dengan gangguan pada sistem-sistem tersebut.
2. Pola kontak kaki-lantai. Kondisi yang berhubungan dengan n.peroneal dapat menyebabkan *drop foot*. Pada keadaan ini, saat berjalan bagian kaki pasien yang lebih dulu menyentuh lantai adalah jempol kaki, diikuti telapak kaki, terakhir tumit.
3. Jarak antar langkahdapat memendek pada pasien dengan penyakit Parkinson. Pada keadaan ii juga dapat dilihat ayunan tangan berkurang saat pasien berjalan.
4. Pada pemeriksaan Romberg, dinyatakan positif bila pasien terlihat berayun atau pemeriksa harus memegang pasien untuk mencegah pasien terjatuh.
5. Apabila pasien terganggu koordinasinya hanya saat pasien menutup mata, maka pasien mengalami gangguan koordinasi karena proprioseptif yang tidak adekuat. Kondisi ini juga dikenal dengan ataksia sensoris.
6. Bila gangguan koordinasi meningkat saat pasien menutup mata, maka pasien mengalami gangguan koordinasi disebabkan oleh kondisi vestibular.
7. Bila gangguan koordinasi sama saat pasien menutup maupun membuka mata, maka gangguan koordinasi ini disebabkan oleh kondisi cerebela.
8. Tes telunjuk hidung tidak terganggu pada pasien dengan gangguan ekstrapirimal, namun mungkin terdapat tremor yang hilang bila pasien

diminta melakukan gerakan yang bertujuan. Namun saat berdiri dan berjalan, pasien mengalami kesulitan akibat adanya gerakan involunter yang berlebihan.

82

Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer |

diminta melakukan gerakan yang bertujuan. Namun saat berdiri dan berjalan, pasien mengalami kesulitan akibat adanya gerakan involunter yang berlebihan, seperti pada pasien Parkinson.

Referensi

1. Bickley. Bates Guide to Physical Examination and History Taking 8th Edition. 2002-08.
2. Duijnhoven, Belle. Skills in Medicine: Neurology Examination. 2009.

24. Pemeriksaan Neurologis Lainnya: Patrick dan Kontra Patrick

Tingkat Keterampilan: 4A

Tujuan

Melakukan pemeriksaan Patrick dan kontra Patrick

Alat dan Bahan: -

Teknik Pemeriksaan

1. Siapkan alat dan bahan.
2. Jelaskan kepada pasien jenis dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan.
3. Minta pasien berbaring di meja periksa dengan kedua tungkai diluruskan.
4. *Patrick's sign*
 - a. Pemeriksa melakukan fleksi sendi lutut, abduksi dan internal rotasi pada salah satu tungkai pasien.
 - b. Salah satu tangan pemeriksa diletakkan pada anterior superior os iliaka untuk menstabilkan panggul, sedangkan tangan lainnya diletakkan pada lutut pasien yang fleksi kemudian ditekan.
 - c. Nilai adakah nyeri dan lokasinya, bandingkan tungkai kanan dan kiri.

83

Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer |



Gambar 30. *Patrick's sign*

5. ***Contra-patrick's sign***
 - a. Pemeriksa melakukan fleksi sendi lutut, abduksi dan eksternal rotasi pada salah satu tungkai pasien.
 - b. Salah satu tangan pemeriksa diletakkan pada anterior superior os iliaka untuk menstabilkan panggul, sedangkan tangan lainnya diletakkan pada lutut pasien yang fleksi kemudian ditekan.
 - c. Nilai adakah nyeri dan lokasinya, bandingkan tungkai kanan dan kiri.

Analisis hasil pemeriksaan

Patrick's sign

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengevaluasi kelainan pada sendi panggul atau sendi sakroiliaka. Jika rasanyeri timbul pada sisi ipsilateral anterior, maka hal ini menandakan adanya gangguan sendi panggul pada sisi ipsilateral. Jika nyeri timbul pada sisi kontralateral posterior sekitar sendi panggul, maka hal ini menandakan adanya kelainan pada sendi tersebut.

Contra-patrick's sign

Pemeriksaan ini merupakan kebalikan dari tindakan *patrick's sign*. Bila nyeri timbul pada pemeriksaan ini, maka hal ini menandakan adanya kelainan pada sendi sakroiliaka.

Referensi

Buckup K. Clinical test for the musculoskeletal system: examinations-signs-phenomena. 2nd ed. Stuttgart: Thieme; 2008.